Metodenotat

Dette dokumentet er et metodenotat til det uavhengige forskningsprosjektet *Pasientkrav, standardisering og lokal variasjon i digital sykehusinformasjon*. Formålet er å dokumentere datamaterialet, kodingen og analysene som ligger til grunn for prosjektet, og å gjøre fremgangsmåten etterprøvbar.

Forfatter: Roy Aulie Jacobsen
Prosjekt: Uavhengig forskningsprosjekt
Dato: 2. oktober 2026

1. Hensikt

Hensikten med prosjektet er å undersøke hvilke oppgaver digital pasientinformasjon legger på pasienten før behandling eller undersøkelse, og hvor lik eller ulik informasjonen er når den samme behandlingen beskrives ved forskjellige helseforetak.

Pasientinformasjon skal ikke bare leses og forstås. Den skal ofte også omsettes i handling. For pasienten kan dette innebære å endre medisinbruk, faste, gjennomføre hygieneprosedyrer, planlegge transport, kontakte helsepersonell, holde styr på flere tidspunkter og forholde seg til betingelser som endrer hva vedkommende skal gjøre.

Prosjektet undersøker derfor pasientinformasjon som mer enn bare tekst. Analysen retter oppmerksomheten mot hvilke konkrete krav informasjonen stiller til pasienten, og hvordan disse kravene varierer mellom behandlinger og helseforetak.

2. Datamateriale og utvalg

Datamaterialet består av offentlig tilgjengelig pasientinformasjon på nettsidene til Vestre Viken HF, Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF. Det ble valgt ut 16 behandlinger og undersøkelser som ble undersøkt ved hvert av de fem helseforetakene. Dette gir et balansert datasett med 80 analyseenheter (16 × 5). En analyseenhet tilsvarer en nettside om en behandling eller undersøkelse ved ett helseforetak. Alle nettsidene ble hentet og kodet 1. oktober 2026.

Utvalget omfatter koloskopi, MR-undersøkelse, CT-undersøkelse, bronkoskopi, lyskebrokkoperasjon, galleblæreoperasjon, elektrokonvertering, brystkreftoperasjon, spirometri, EKG, mammografi, spinalpunksjon, EEG, gynekologisk undersøkelse, arbeids-EKG og ultralyd av hjertet. Utvalget er satt sammen for å muliggjøre sammenligninger mellom behandlinger og helseforetak, og er ikke ment å være statistisk representativt for all pasientinformasjon i norsk spesialisthelsetjeneste.

Helt kort består datagrunnlaget av:

- 80 nettsider
- 16 behandlinger og undersøkelser × 5 helseforetak
- Tilgangsdato: 1. oktober 2026

- Metode: manuell, deskriptiv innholdsanalyse
- Koding utført av en forsker: Roy Aulie Jacobsen

3. Manuell innholdsanalyse og koding

Hver nettside ble gjennomgått og kodet manuelt av én koder, Roy Aulie Jacobsen. Hovedteksten på nettsiden ble lest og kodet for eksplisitte krav til pasienten før eller i forbindelse med behandling eller undersøkelse.

Når en nettside henviste videre til innkallingsbrev, fastlege, telefonisk beskjed eller andre dokumenter, ble dette registrert som ekstern informasjon. Innholdet i slike eksterne kilder ble ikke kodet som en del av hovedteksten. Analysen beskriver derfor informasjonen som var tilgjengelig på den undersøkte nettsiden, og ikke hele informasjonskjeden en enkelt pasient kan motta.

Operasjonalisering

Handling: En oppgave pasienten forventes å gjøre eller unnlate å gjøre før eller i forbindelse med oppmøte, for eksempel å faste, endre medisinbruk eller kontakte avdelingen.

Tidskrav: Et tidspunkt, tidsvindu, frist eller rekkefølgekrav som pasienten må holde styr på.

Betingelse: Et vilkår som endrer hva pasienten skal gjøre, for eksempel avhengig av medisinbruk, helsetilstand eller andre forhold.

Kravtyper: Binære indikatorer for om nettsiden inneholder minst ett krav knyttet til medisin, mat eller faste, hygiene, transport, å ta med noe, kontakt eller varsling, ekstern informasjon, sikkerhetsscreening eller konsekvens ved avvik.

Lokal variant: Binær indikator for om den undersøkte nettsiden inneholder informasjon som avviker fra den standardiserte teksten som brukes for den samme behandlingen eller undersøkelsen.

4. Analyse

Analysene i prosjektet er deskriptive. De omfatter gjennomsnitt og fordelinger for handlinger, tidskrav og betingelser, forekomst av konkrete kravtyper, samt sammenligninger mellom behandlinger og helseforetak. I tillegg gjennomføres en deskriptiv variansdekomponering i det balanserte 16 × 5-designet for å beskrive hvor mye av den observerte variasjonen som er knyttet til behandlingstype, helseforetak og resterende variasjon.

Analysene er gjennomført i R. Syntaksen som følger prosjektet bruker blant annet pakkene tidyverse og readxl, og gjør det mulig å reprodusere hovedanalysene, tabellene og figurene direkte fra den delbare datafilen.

5. Begrensninger

- Studien analyserer dokumenter, ikke pasienter. Den måler derfor ikke faktisk forståelse, hukommelse, etterlevelse eller pasientsikkerhetsutfall.

- Klinisk korrekthet, lesbarhet, språkvalg og universell utforming er ikke vurdert systematisk. Antall registrerte krav skal derfor ikke forstås som en kvalitetsscore.
- Kodingen er gjennomført av én forsker. Det er ikke beregnet interkoderreliabilitet, og enkelte grensedragninger kan være skjønnsmessige.
- Materialet er et øyeblikksbilde fra 1. oktober 2026. Nettsider kan endres over tid, og deler av den klinisk relevante informasjonen kan ligge i innkallingsbrev eller gis individuelt.
- Utvalget omfatter fem helseforetak og 16 behandlinger og undersøkelser. Resultatene er derfor ikke ment å generaliseres statistisk til all digital pasientinformasjon i norsk spesialisthelsetjeneste.

6. Delbar datafil og reproduksjon

Den delbare Excel-filen er en ryddet versjon av arbeidsdatasettet. Hovedarket «Data» inneholder variablene som brukes i de deskriptive analysene. Arket «Kodebok» beskriver variablene og kodingen, mens «Detaljkoding» inneholder de manuelle tekstbeskrivelsene som ligger til grunn for tellingene og vurderingen av lokal variasjon. Detaljkodingen er inkludert for å gjøre datagrunnlaget mest mulig transparent og etterprøvbart. Arbeidsnotater og andre mellomprodukter er ikke inkludert.

Datasettet inneholder ikke pasientdata eller personopplysninger om pasienter. Kildematerialet består av offentlig tilgjengelige institusjonelle nettsider. URL og tilgangsdato er bevart for hver analyseenhet, slik at datagrunnlaget kan etterprøves så langt de opprinnelige nettsidene fortsatt er tilgjengelige.

R-syntaksen som følger datasettet, dokumenterer databehandlingen og analysene og kan brukes til å reprodusere tabeller og figurer fra den delbare datafilen.